



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE

GABRIELLA NUNES DA LUZ MORELO

**CORRELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE GORDURA E APRECIÇÃO
CORPORAL E SEUS POSSÍVEIS MEDIADORES EM INDIVÍDUOS ADULTOS
EUTRÓFICOS E COM OBESIDADE**

Porto Alegre

2026

GABRIELLA NUNES DA LUZ MORELO

**CORRELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE GORDURA E APRECIÇÃO
CORPORAL E SEUS POSSÍVEIS MEDIADORES EM INDIVÍDUOS ADULTOS
EUTRÓFICOS E COM OBESIDADE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Carolina Guerini de Souza

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Nunes da Luz Morelo, Gabriella
CORRELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE GORDURA E APRECIAÇÃO
CORPORAL E SEUS POSSÍVEIS MEDIADORES EM INDIVÍDUOS
ADULTOS EUTRÓFICOS E COM OBESIDADE / Gabriella Nunes
da Luz Morelo. -- 2026.
58 f.
Orientador: Carolina Guerini de Souza.

Dissertação (Mestrado Profissional) -- Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina,
Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e
Saúde, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Imagem Corporal; Satisfação com o corpo;
Composição Corporal; Estigma do Peso. I. Guerini de
Souza, Carolina, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

GABRIELLA NUNES DA LUZ MORELO

**CORRELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE GORDURA E APRECIÇÃO
CORPORAL E SEUS POSSÍVEIS MEDIADORES EM INDIVÍDUOS ADULTOS
EUTRÓFICOS E COM OBESIDADE**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Alimentação, Nutrição e Saúde.

Aprovada em: 27/02/2026

BANCA EXAMINADORA

Profª Drª Jussara Carnevale de Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profª Drª Lisiane Bizarro Araújo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profª Drª Zilda Elisabeth de Albuquerque Santos
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Orientadora - Profª Drª Carolina Guerini de Souza
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

AGRADECIMENTOS

Escrevi e reescrevi estes agradecimentos inúmeras vezes, tentando encontrar o ponto de partida em meio a tantas pessoas e histórias que me trouxeram até aqui. Concluir um mestrado em uma das melhores universidades do país é mais do que um marco acadêmico é a lembrança viva de todos os caminhos percorridos, das dores enfrentadas e, principalmente, da coragem necessária para me libertar de uma relação abusiva e reconhecer que eu mereço ser feliz.

Não sei exatamente em que momento me perdi, mas sei com absoluta clareza o instante em que me reencontrei. Foi aí que entendi que, aconteça o que acontecer, a história sempre continua. Talvez tenha sido destino, talvez não, ainda não sei se acredito nisso, mas sei que muitas pessoas fizeram e continuam fazendo parte dessa jornada.

Cresci católica, embora hoje eu evite rótulos. Ainda assim, é impossível não reconhecer a presença constante de Deus ao meu lado. Sou profundamente grata por tudo o que Ele tem permitido florescer na minha vida.

Agradeço à minha família, Cirilo, Rosângela e Gustavo, meus amores e pilares. Eles são uma das grandes razões pelas quais não desisti, mesmo quando o medo apertava. Cada um, à sua maneira, sempre segurou a minha mão.

Milena, obrigada por me ajudar a sair de um lugar que só nós duas conhecemos. Você me acolheu quando eu mais precisava e enxergou em mim muito além do óbvio. Continuamos costurando juntas laços fortes e belíssimos.

Natasha, jamais esquecerei a confiança que depositou em mim, no meu trabalho e nas palavras que mudaram tudo: “eu encontrei um diamante que só precisava ser lapidado”. Obrigada por acreditar antes mesmo que eu acreditasse.

À minha orientadora, professora Carol, obrigada por embarcar comigo nessa jornada, por me receber de braços abertos e por sempre observar minhas dificuldades com humanidade.

Ao Grupo OMETÁ, um coletivo multidisciplinar que resistiu ao caos cotidiano e entregou o seu melhor, deixo minha gratidão especial a Gabi Rocha, Artur, Gabi Ferrari e Marcella. Só quem viveu sabe o quanto essa travessia foi intensa.

Aos meus amigos e amigas espalhados entre Lagoa Vermelha, Tapejara, Erechim e Porto Alegre: somos um mosaico de loucura, amor e diversão. A distância física nunca será capaz de enfraquecer o carinho que nos une. Obrigada por serem porto, riso e refúgio.

E aos meus bebês caninos, Tommy, meu mini-mestrinho e Alvin, sempre feliz, obrigada pela companhia diária e pelas pequenas alegrias que iluminam qualquer dia difícil.

O corpo vem recebendo das ciências o mesmo tratamento dado às máquinas da era industrial. Contamos calorias, inputs, outputs, gastos, massas magras/gordas e aproveitamentos. É o corpo máquina, quantificado, que se expressa em controles cada vez mais elaborados e rigorosos. É a compulsão, a fome, o medo. São os excessos e as privações. Parece que o corpo nunca cabe no corpo, algo sobra, não se ajusta e resulta na necessidade de aumentar ainda mais o controle sobre o corpo. Dessa eterna luta nós saímos fracassados, decepcionados, descontrolados ou deprimidos. Há outra maneira de olhar, cuidar e tratar o corpo?

Luciana Saddi

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -	Fluxograma das etapas da pesquisa	27
Figura 2 -	Modelo de mediação múltipla entre percentual de gordura corporal e apreciação corporal, tendo vergonha e sintomas de ansiedade como variáveis mediadoras. O caminho direto (c') representa o efeito do percentual de gordura corporal sobre a apreciação corporal, controlando os efeitos das variáveis mediadoras. Os caminhos a_1 e a_2 correspondem aos efeitos de gordura corporal sobre vergonha e sintomas de ansiedade, respectivamente. Os caminhos b_1 e b_2 representam os efeitos de vergonha e sintomas de ansiedade sobre a apreciação corporal.	34
Figura 3 -	Modelo de mediação múltipla entre percentual de gordura corporal (X) e apreciação corporal (Y), com autocompaixão (M) como variável mediadora. O caminho direto (c') representa o efeito de X sobre Y, controlando os efeitos das mediações. O caminho a indica o efeito de gordura corporal sobre autocompaixão, respectivamente, e o caminho b indica o efeito dessa variável mediadora sobre a apreciação corporal.	36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Caracterização da amostra (n= 207)	31
Tabela 2	Análise de correlação entre percentual de gordura, apreciação corporal, vergonha, sintomas de ansiedade e autocompaixão (n = 207).....	32
Tabela 3	Mediações das variáveis percentual de gordura, sintomas de ansiedade, vergonha e apreciação corporal	33
Tabela 4	Mediações das variáveis percentual de gordura, autocompaixão e apreciação corporal	35

LISTA DE ABREVIATURAS

ABESO	Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANS	Agência Nacional de Saúde Suplementar
APA	<i>American Psychiatric Association</i>
BAS	<i>Body Appreciation Scale</i>
BISS	<i>Body Image Shame Scale</i>
BMI	<i>Body Mass Index</i> (Índice de Massa Corporal)
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CPC	Centro de Pesquisa Clínica
DCNT	Doenças Crônicas não Transmissíveis
DP	Desvio Padrão
GAD	<i>Generalized Anxiety Disorder</i>
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IC	Intervalo de Confiança
IMC	Índice de Massa Corporal
OAS	<i>Other as Shamer Scale</i>
OMS	Organização Mundial da Saúde
PA	Pressão Arterial
SCS	<i>Self-Compassion Scale</i>
SPSS	<i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
TAG	Transtorno de Ansiedade Generalizada
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
VIGITEL	Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
WHO	<i>World Health Organization</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 REVISÃO DA LITERATURA	15
2.1 PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL.....	15
2.2 APRECIÇÃO CORPORAL	17
2.3 VERGONHA.....	18
2.4 SINTOMAS DE ANSIEDADE	20
2.5 AUTOCOMPAIXÃO.....	21
3 JUSTIFICATIVA	24
4 OBJETIVOS	25
4.1 OBJETIVO GERAL.....	25
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	25
5 MÉTODOS.....	26
5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO E AMOSTRA	26
5.2 PARTICIPANTES	26
5.3 LOGÍSTICA	26
5.4 AVALIAÇÕES REALIZADAS E INSTRUMENTOS APLICADOS.....	27
5.5 CÁLCULO AMOSTRAL	30
5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	30
6 RESULTADOS.....	31
6.1 ANÁLISES DE CORRELAÇÃO	31
6.2 ANÁLISES DE MEDIAÇÃO.....	32
6.2.1 Sintomas de ansiedade e vergonha como mediadores.....	32
6.2.2 Autocompaixão como mediadora.....	34
7 DISCUSSÃO	37
8 CONCLUSÃO.....	41
REFERÊNCIAS	42
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	50
APÊNDICE B - PESQUISA SOBRE COMPORTAMENTO ALIMENTAR E ANSIEDADE.....	52
APÊNDICE C - ORIENTAÇÃO PARA EXAMES	53
ANEXO A - TRANSTORNO DE ANSIEDADE GAD - 7	54

ANEXO B - ESCALA DE APRECIACÃO CORPORAL <i>BODY APPRECIATION</i>	
<i>SCALE – 2 (BAS – 2)</i>.....	55
ANEXO C - ESCALA DE AUTOCOMPAIXÃO - <i>SELF-COMPASSION SCALE</i>	
<i>(SCS)</i>.....	56
ANEXO D - ESCALA DA VERGONHA <i>OTHER AS SHAMER SCALE (OAS)</i>.....	59

1 INTRODUÇÃO

A apreciação corporal envolve a aceitação, o respeito e uma visão positiva do próprio corpo, e tem sido considerada um conceito que ganha cada vez mais relevância numa sociedade dominada por padrões de beleza muitas vezes inatingíveis (Tylka *et al.*, 2015). Tal apreciação, da visão fenotípica do corpo idealizado, tem íntima ligação com o bem-estar físico e mental, onde os padrões de beleza impostos pela mídia e pela sociedade, se rejeitados, podem propiciar uma relação mais saudável com a própria aparência, valorizando características individuais. Entretanto, essa rejeição também pode ser um viés que impeça o indivíduo de buscar meios de alcançar um corpo saudável, dificultando a adesão a orientações e ações educativas para mudanças de hábitos alimentares e de vida, visando a prevenção de doenças (Godoy-Izquierdo *et al.*, 2020).

Em um cenário global onde mais de 650 milhões de adultos vivem com obesidade, a obesidade se torna uma barreira importante para a apreciação corporal, World Health Organization (OMS, 2022). O excesso de gordura corporal aumenta o risco de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias e muitas outras complicações clínicas (GBD 2021; Risk Factors Collaborators, 2024). Porém, na maioria das vezes, é a insatisfação corporal, bem como a falta de apreciação corporal, que leva as pessoas a procurarem por um tratamento, sendo com médicos, psicólogos ou nutricionistas (Gruszka *et al.*, 2021).

Vivemos numa sociedade que preconiza a magreza como belo, e divergir desse padrão dominante pode ser desafiador e suscitar emoções desagradáveis autoconscientes, assim a relação com o corpo pode ser considerada como um objeto de consumo (Yahia *et al.*, 2011; Vizin, 2022; Raspovic, 2023). Contudo, esse ideal de beleza é muitas vezes inatingível, ocasionando decepção, culpa e vergonha. Estudos sobre o estigma do peso, a autoavaliação e autocritica em relação a grupos sociais específicos ou geral, bem como idealizado, revelam que tais percepções poderiam explicar o sentimento de inferioridade dos indivíduos com peso elevado, bem como o de não pertencimento à comunidade em que vivem. Além disso, é possível relacionar tais emoções como fatores de risco para alteração da ingestão alimentar, correlacionando o alimento como um agente de fuga de emoções desagradáveis (Lucicello *et al.*, 2020; Braun *et al.*, 2021).

A imagem corporal é como uma pessoa vê seu próprio corpo, sendo uma parte fundamental de sua identidade, compreendendo a imagem que se tem de suas próprias formas e contornos corporais, junto das emoções ligadas a esses aspectos que afetam a apreciação em

relação à aparência do corpo ou suas áreas específicas (Solomon-Krakus; Sabiston, 2017). Essa imagem corporal é construída e constantemente reavaliada ao longo do tempo, com base nas interações do indivíduo com o ambiente social, onde tem como precursor percepções, suposições e representações imaginativas acerca do impacto da própria imagem sobre os outros, bem como pelas avaliações que estes realizam (Oliveira; Machado, 2021). Soma-se a esse processo um componente subjetivo de autopercepção, manifestado em sentimentos como orgulho ou vergonha, que emergem das dinâmicas de interação social (Brasil *et al.*, 2024).

A falta de apreciação corporal ou imagem corporal negativa, não afeta apenas crianças ou adolescentes, embora a maioria dos estudos concentre-se nesse público (Zanolli *et al.*, 2019; Pinhão *et al.*, 2023). Indivíduos adultos que vivenciaram essas fases sem o devido suporte emocional, aconselhamento adequado ou intervenções específicas podem apresentar dificuldades na gestão da vergonha, baixa autoestima, depressão, ansiedade e comportamentos alimentares disfuncionais. Em casos mais graves, como os transtornos alimentares, a imagem corporal negativa frequentemente decorre da carência de atitudes positivas em relação ao próprio corpo, refletindo-se em desafios persistentes ao longo da vida adulta (Secchi *et al.*, 2009; Tylka; Barcalow, 2015; Gattario *et al.*, 2015; Burcu, 2021).

Dessa forma, uma maior compreensão dessa relação para necessária, para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes na promoção de uma imagem corporal positiva e no manejo do peso, onde alguns estudos informam, ainda, que a apreciação da imagem corporal ou imagem corporal positiva pode ser desenvolvida através das habilidades de autocompaixão (Turk *et al.*, 2021; Toole *et al.*, 2021; Braun *et al.*, 2021).

A autocompaixão pode ser definida como estar atento, compreender e cuidar de si durante momentos desafiadores e de sofrimento (Neff, 2003), sendo pautada, também, pela compreensão, paciência e autoperdão, sem julgamento em relação ao fracasso ou erros (Homan, 2015). As intervenções de autocompaixão visam promover uma melhor regulação emocional, abordando as emoções desagradáveis através da autobondade, em vez de culpa, autocrítica, vergonha e ansiedade (Neff; Germer, 2013; Berking *et al.*, 2014).

A relação entre apreciação corporal e percentual de gordura corporal, bem como a vergonha e os sintomas de ansiedade como possíveis mediadores nessa relação, e elevados níveis de autocompaixão como fator protetivo, ainda não estão completamente compreendidas na literatura atual, havendo necessidade de entender possíveis efeitos destas variáveis.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A imagem corporal é a forma como uma pessoa vê seu próprio corpo, constituindo uma parte fundamental de sua identidade. Essa percepção pode ser caracterizada pela imagem que se tem de suas próprias formas e contornos corporais, junto das emoções ligadas a esses aspectos que afetam a apreciação em relação à aparência do corpo ou a áreas específicas dele (Silva *et al.*, 2018). Cash e Fleming (2002) afirmam que tanto as experiências passadas, influências culturais, como a exposição da mídia e as vivências sociais desempenham um papel fundamental na formação e na sustentação das experiências relacionadas à percepção do corpo, de modo que as influências do passado predispõem as opiniões e as emoções de uma pessoa em relação à sua imagem corporal.

A imagem corporal é construída e constantemente reavaliada ao longo do tempo com base nas interações do indivíduo com o ambiente social. Esse constructo é moldado por percepções, suposições e representações imaginativas acerca do impacto da própria imagem sobre os outros, bem como pelas avaliações que estes realizam (Oliveira; Machado, 2021).

2.1 PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL

Conforme a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) (2021), mais de 60% dos brasileiros apresentam excesso de peso (sobrepeso ou obesidade), revelando que em cada quatro pessoas sofre dessa doença. Vários elementos influenciam esse crescimento, considerando que a obesidade é uma condição complexa, fruto da interação entre elementos genéticos, neuroquímicos, ambientais e psicossociais (WHO, 2022).

Na sociedade atual, a obesidade ainda sofre forte estigma social fundamentado não apenas por padrões de beleza irreais, mas por processos mais amplos de moralização do corpo, ideologias de responsabilidade individual e interpretações reducionistas do peso corporal levando à discriminação em ambientes sociais, isolamento, baixa autoestima e sofrimento psicológico (Wachholz; Santos; Ribeiro, 2022). Essa visão estigmatizante prejudica o acesso a cuidados adequados e dificulta intervenções eficazes, tornando urgente combater o preconceito e promover uma compreensão mais humanizada da condição a fim de construir uma sociedade mais inclusiva e promover uma assistência mais eficiente (Phelan *et al.*, 2015).

A obesidade, além de seus impactos físicos, influencia profundamente como o corpo é percebido e avaliado. Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) (2021) em relação aos estudos realizados anteriormente pela instituição, a prevalência de sobrepeso e obesidade tem crescido. A literatura aponta que pessoas com maior percentual de gordura corporal tendem a apresentar menor apreciação corporal, frequentemente por vivenciarem estigmatização e julgamento social (Gruszka *et al.*, 2021; Carter, 2021).

O preconceito social em relação ao excesso de peso tem um grande impacto na maneira como as pessoas com maior IMC enxergam e valorizam seus próprios corpos. Muitas vezes essas pessoas enfrentam rejeição e discriminação, o que pode dificultar a aceitação de si mesmas e o respeito pelo próprio corpo (Robbins; Reissing, 2018). Essa ideia negativa, muitas vezes reforçada pelos meios de comunicação, acaba levando à internalização desses valores, dificultando que elas tenham uma relação mais positiva com seu corpo, mesmo que ele funcione bem (Robinson *et al.*, 2017). Além disso, o gênero também influencia essa questão: as mulheres, em geral, sentem mais pressão social para se encaixar em padrões de magreza, o que aumenta a relação negativa entre ter um IMC mais alto e a baixa autoestima corporal (J. He *et al.*, 2020).

Razmus (2018) afirmou em seu artigo que indivíduos com excesso de peso e obesidade apresentaram níveis significativamente mais baixos de apreciação e orgulho relacionado ao corpo, em comparação com os indivíduos eutróficos. Os achados ainda indicam que a valorização corporal pode estar mais relacionada à percepção de aprovação social, ou seja, ao peso idealizado. Outro estudo apontou que, nos participantes com IMC médio de 31,23 kg/m², caracterizando obesidade, observou-se uma associação significativa entre o aumento do índice de massa corporal e a redução da apreciação corporal, reforçando que o excesso de gordura pode estar relacionado a sentimentos de inadequação e distanciamento em relação ao próprio corpo (Dairi *et al.*, 2023).

O estudo de Weinberger e Luck-Sikorski (2021) realizado com 1003 indivíduos adultos de ambos os sexos, todos com idade acima de 18 anos, demonstrou que o aumento do IMC associou-se a piores escores de apreciação corporal. O estudo também encontrou que sexo, idade, escolaridade, sintomas depressivos e autoestima explicam uma proporção significativa da variabilidade em apreciação corporal. Tais achados reforçam a importância de abordagens que contemplem não apenas aspectos nutricionais, mas que visem também o fortalecimento da autoestima, de modo a promover atitudes positivas em relação ao corpo,

contribuindo para o bem-estar psicológico e maior adesão a tratamentos nutricionais, clínicos ou psicológicos.

2.2 APRECIÇÃO CORPORAL

A investigação sobre imagem corporal, até meados da década de 2000, centrou-se predominantemente nos seus aspectos negativos, com ênfase na aparência física, incluindo peso e forma corporal. No entanto, impulsionados pelos desenvolvimentos na psicologia positiva e pelas primeiras formulações teóricas sobre imagem corporal positiva, emergiu o conceito de apreciação corporal, formalizado por Avalos e colaboradores (2005) através da Body Appreciation Scale (BAS) (Cash; Smolak, 2011).

A valorização corporal refere-se à aceitação, ao respeito e à apreciação positiva do próprio corpo, independentemente de sua conformidade com os padrões socioculturais de estética (Tylka *et al.*, 2015). Esse conceito tem adquirido relevância na literatura como um indicador significativo de bem-estar físico e psicológico, promovendo atitudes mais saudáveis e diminuindo comportamentos de risco, como comportamento alimentar desadaptativo associados à imagem corporal (Linardon *et al.*, 2023). Em contraste com a insatisfação corporal, a valorização corporal visa fortalecer uma relação de cuidado com o corpo e suas particularidades.

Estudos sobre a percepção corporal positiva e associação com o ideal de magreza difundido pela mídia globalizada têm diferenças quanto a relação cultural de mulheres e seu ambiente sociodemográfico, podendo refletir uma visão mais realista da composição corporal, maior aceitação e apreciação das características corporais, embora a interpretação destes estudos requeira cuidados, uma vez que as diferenças encontradas foram pequenas, não sendo significativas, mas podendo indicar a importância da autoaceitação na percepção corporal dessas mulheres quando o meio sociocultural seja semelhante (Tilka; Wood-Barcalow, 2015).

Assim, a apreciação corporal é fundamental para a formação da imagem positiva, podendo ser incentivada de forma eficaz por ações educativas que enfatizem a funcionalidade do corpo, englobando a ideia de que a percepção corporal positiva não significa ausência de insatisfação corporal, uma vez que ela representa um modelo de integração e resiliência que abrange apreciação, aceitação, autoestima e atitudes de cuidado pessoal (Wood-Barcalow *et al.*, 2010; Guest *et al.*, 2019).

O estudo de Linardon e colaboradores (2022) mostraram que a apreciação corporal estava negativamente associada à restrição alimentar e à internalização de ideais de aparência,

vigilância corporal e pressões socioculturais, bem como a depressão e ansiedade. Todavia, ela estava positivamente correlacionada com autoestima, autocompaixão e satisfação sexual, de modo que tais descobertas confirmam que a valorização corporal é um preditivo para uma melhor saúde física e mental.

Os resultados do estudo de Andrew e colaboradores (2016) revelaram que altos níveis de apreciação corporal estão significativamente associados a uma maior aceitação corporal percebida, além de elevada autocompaixão, menor exposição ao conceito da beleza estereotipada apresentada nas redes sociais que refletiria uma menor autoaceitação do próprio corpo em grupos sociais. Neste pensamento, Swami e colaboradores (2024) mostraram que cultivar uma relação positiva com o corpo implicaria numa associação positiva da saúde corporal com a saúde mental, mediada pela autoeficácia, pela resiliência e pela valorização da vida.

Estudos sobre percepção corporal, obesidade e estado emocional têm sido realizados para compreender como essa dinâmica interfere na saúde e qualidade de vida, onde Raspovic e colaboradores (2023) demonstraram que elevados níveis de apreciação corporal estão relacionados à redução do sentimento de vergonha, atuando como um mecanismo de defesa contra comportamentos prejudiciais, como restrição alimentar, principalmente em indivíduos com maior índice de massa corporal (IMC). Enquanto Weinberger e colaboradores (2016) exploraram a apreciação corporal em indivíduos com obesidade e os resultados apontaram que quanto maior for o nível de insatisfação com a aparência, maior o IMC de ambos os sexos. Tais estudos destacaram o potencial da apreciação corporal como um recurso importante para abordar questões relacionadas à imagem, especialmente para pessoas com obesidade, sugerindo que intervenções destinadas a aumentar a apreciação corporal poderão ajudar a melhorar o bem-estar psicológico nessa população.

Embora existam pesquisas que apoiam os resultados mencionados, o número de estudos conduzidos com adultos ainda é restrito. A maioria das pesquisas é direcionada a crianças ou adolescentes (Laporta-Herrero *et al.*, 2022; Guest *et al.*, 2022). Assim, ainda é necessário explorar como a apreciação corporal positiva pode impactar o cotidiano de adultos, visando promover uma melhor qualidade de vida.

2.3 VERGONHA

A vergonha é uma emoção autoconsciente que surge da percepção de julgamento negativo, real ou imaginário do indivíduo em relação aos seus pares. Estudos têm

demonstrado que a vergonha, especialmente a relacionada à imagem corporal, atua como um fator mediador entre o percentual de gordura e a insatisfação corporal. Indivíduos com corpos fora dos padrões estéticos socialmente aceitos podem sentir-se constantemente avaliados e desvalorizados (Lucibello, 2020; Mendes *et al.*, 2021).

A vergonha externa da imagem corporal, definida como a percepção de julgamento negativo em relação ao corpo, caracteriza-se como uma importante fonte de sofrimento emocional e pode estar ligada a comportamentos alimentares disfuncionais (Marta-Simões *et al.*, 2016). De acordo com Salarian e colaboradores (2021) essa relação se manifesta tanto em homens, quanto em mulheres, sendo mais intensa no sexo feminino. A vergonha externa, assim como a interna, está associada a diferentes formas de autocritica: em homens, caracterizada por sentimentos de inferioridade e inadequação, e em mulheres é marcada pelo autodepreciação corporal, o que evidencia maior vulnerabilidade diante da vergonha externa (Melo *et al.*, 2020).

Padrões de beleza e a estigma do peso, podem gerar vergonha externa, que está frequentemente associada a desmotivação ou falta de controle, uma vez que ao ser internalizada essa vergonha pode desencadear comportamentos de introspecção, especialmente em cenários nos quais o corpo está sujeito à exposição pública, como academias, ginásios ou qualquer ambiente de prática esportiva (Lucibello *et al.*, 2020). Solomon e Sabiston (2017) relataram que mulheres apresentaram níveis mais significativos em relação à vergonha e culpa corporal quanto ao peso e maior frequência de comportamentos de verificação corporal quando comparados com os homens.

Raspovic e colaboradores (2023) mensuraram a vergonha corporal com base em afirmações como “eu sentiria vergonha se descobrissem minhas medidas”, imagem corporal, apreciação corporal e IMC, os resultados deste estudo sugerem que a interação entre essas variáveis influencia de forma importante o modo como as mulheres gerenciam sua alimentação e a prática de exercícios físicos. Isso evidencia um tipo de vergonha externa, ligado ao receio de julgamento social à exibição pública do corpo, pois a mesma é desenvolvida a partir de interações sociais, essas experiências influenciam o comportamento posterior em contextos interpessoais ou culturais (Cunha *et al.*, 2016).

Segundo Czepczor-Bernat (2022), a vergonha gerada pela associação de sentimentos desagradáveis quanto à imagem corporal pode ter ligação com um ideal de beleza que ainda tem grande influência no comportamento biopsicossocial, uma vez que esse ideal é por vezes inatingível devido às próprias características genéticas dos indivíduos. Esse padrão idealizado e amplamente divulgado na mídia física e digital, que destaca um corpo feminino magro, com

aparência jovial e quase esteticamente perfeito pode ter íntima relação com o desencadeamento de transtornos diversos, como o transtorno alimentar, depressão, ansiedade e deterioração do funcionamento mental, se caracteriza como uma complicação à saúde que pode ser significativa e abalar o bem-estar e a qualidade de vida (Sanzari *et al.*, 2023).

O sentimento de vergonha externa tem sido apontado como um fator antecedente importante no desenvolvimento da compulsão alimentar, especialmente em indivíduos com obesidade (Nechita; David, 2023). Este processo é especialmente crítico nestes indivíduos, justamente por serem expostos ao estigma social e, conseqüentemente, à vergonha interna e externa, o que prejudica o autocuidado e complica a adesão a tratamentos clínicos. Ademais, a forma externa de vergonha, atrelada à exposição do corpo ao olhar alheio, apresentou uma forte correlação com comportamentos alimentares disfuncionais (O’Loghlen *et al.*, 2021).

2.4 SINTOMAS DE ANSIEDADE

Os sinais e sintomas de ansiedade estão relacionados a respostas fisiológicas emitidas pelo organismo humano diante de situações percebidas como ameaçadoras ou estressoras. Trata-se de uma reação natural e adaptativa, presente em todos os indivíduos, que têm como função preparar o corpo para lidar com desafios e perigos. No entanto, quando essas respostas se tornam frequentes, intensas ou desproporcionais ao contexto, passam a gerar sofrimento e prejuízos funcionais afetando milhares de pessoas em todo o mundo, se manifestando através de uma variedade de sintomas que abrangem aspectos cognitivos, emocionais, fisiológicos e comportamentais (APA, 2022; WHO, 2025). Quando esses sintomas se tornam persistentes ou intensos, podem evoluir para um quadro de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), caracterizado por preocupações excessivas e difíceis de controlar. Esse transtorno manifesta-se tanto por sinais psicológicos, como agitação mental, irritabilidade e fadiga constante, quanto por sintomas físicos, incluindo tensão muscular, sudorese, tremores, aceleração dos batimentos cardíacos e dificuldades respiratórias (APA, 2022; Alonso *et al.*, 2018; Bullis *et al.*, 2023).

A ansiedade também pode estar diretamente relacionada à imagem corporal, expressando-se como uma preocupação intensa com o peso e a aparência física. Nesse contexto, ela pode assumir um caráter ambivalente ao longo do processo de emagrecimento, englobando tanto o medo de engordar quanto o receio de parecer excessivamente magro (Styk *et al.*, 2023). O estudo de Figueroa e colaboradores (2025) destaca que o estigma relacionado

ao peso corporal tem impacto significativo na saúde mental, especialmente na intensificação dos sintomas de ansiedade.

Fatores como vergonha corporal, autocrítica elevada e a busca por padrões estéticos idealizados contribuem significativamente para o agravamento do mal-estar psicológico (Raque *et al.*, 2023). Esses elementos favorecem sentimentos de inadequação, aumentam a hipervigilância em contextos sociais e alimentam o medo persistente de avaliação negativa, afetando diretamente a forma como o indivíduo se relaciona com o próprio corpo (Mills *et al.*, 2022). A aparência, nesses casos, torna-se uma fonte constante de ansiedade e sofrimento emocional (Sick *et al.*, 2020).

Apreciação corporal e ansiedade se correlacionam de maneira opostas em relação a como a pessoa se relaciona com o próprio corpo. Enquanto a apreciação envolve aceitar e valorizar o corpo, a ansiedade de aparência refere-se ao medo intenso de ser avaliado negativamente com base na aparência física, especialmente em ambientes sociais (Bakalim, 2016). Naz e colaboradores (2023) realizaram estudo com 600 universitários, que indicou associação negativa entre apreciação corporal e ansiedade de aparência social, inclusive demonstrou que mulheres apresentam maior satisfação com a vida e satisfação corporal do que homens. Cabe destacar que a ansiedade, mesmo quando não relacionada à aparência, pode intensificar a autocrítica corporal, reforçar a internalização do estigma e impactar negativamente a saúde mental e o bem-estar do indivíduo.

2.5 AUTOCOMPAIXÃO

A autocompaixão tem sido descrita na literatura como um construto psicológico que envolve a capacidade do indivíduo de dirigir a si próprio numa postura de autobondade, compreensão e equilíbrio emocional quando diante da dor, falha e vulnerabilidade (Neff, 2003). Neste conceito psicológico do campo da imagem corporal, a autocompaixão emerge como um possível mecanismo capaz de reduzir a autocrítica. (Homan, 2015).

A autocompaixão envolve três componentes fundamentais: a autobondade que direciona o indivíduo a não se submeter a padrões rigorosos de autocensura, a atenção plena (*mindfulness*) que permite perceber experiências internas com clareza e sem julgamento; além da humanidade compartilhada, que engloba a visão individual sobre o sofrimento e suas causas como parte da sua experiência humana (Neff, 2003). Esses elementos, quando mobilizados de forma integrada, auxiliam na construção de uma relação mais equilibrada com o próprio corpo. Dessa forma, a autocompaixão se destaca como um importante alvo de

intervenção para prevenção e manejo de dificuldades relacionadas à imagem corporal, especialmente em contextos marcados por pressões socioculturais sobre aparência física (Braun; Crystal; Gorin, 2016; Turk; Kellett; Waller, 2021).

Pesquisas têm relatado que a aplicação de programas de intervenção baseados na promoção da autocompaixão favorece a redução de experiências de vergonha, principalmente quanto a imagem corporal, que podem favorecer positivamente a apreciação e o respeito pelo próprio corpo, contribuindo para indicadores que favorecem um maior bem-estar psicológico e controle emocional mais eficaz (Braun; Crystal; Gorin, 2016; Turk; Kellett; Waller, 2021).

Wet e colaboradores (2020) demonstraram que uma intervenção baseada em práticas de atenção plena e autocompaixão gerou efeitos positivos na apreciação e vergonha corporal em de mulheres. Os autores observaram um aumento estatisticamente significativo na apreciação corporal entre as participantes do grupo experimental, em comparação ao grupo controle, refletido em maiores níveis de aceitação, respeito e valorização do corpo. Ainda foi percebido reduções de vergonha corporal e auto imagem baseada na aparência, em comparação ao grupo controle.

A autocompaixão funciona como um recurso psicológico protetor, promovendo a aceitação e reduzindo o julgamento que pode ser expandido para o corpo e a ingestão alimentar (Alvear-Fernández *et al.*, 2021). De acordo com Araya-Véliz e Durán (2022) ser mais autocompassivo pode ajudar a regular melhor as emoções, facilitando uma abordagem mais compreensiva e menos crítica perante falhas alimentares ou sentimentos negativos.

Intervenções voltadas à promoção da autocompaixão podem oferecer uma abordagem assertiva para a melhoria dos indicadores de qualidade de vida e psicoemocional por mediar os efeitos da visão negativa do corpo, ativando um mecanismo de resiliência diante das pressões sociopsicológicas relacionados com os padrões estéticos ainda presente na sociedade global (Duarte *et al.*, 2015; Nightingale; Cassin, 2023).

O estudo qualitativo realizado por Raque e colaboradores (2023) fornece evidências que a autocompaixão contribui para uma imagem corporal mais positiva em mulheres jovens. Foram analisados textos produzidos pelas participantes que realizaram a intervenção de escrita autocompassiva no período de três semanas, fora identificado que uma postura mais acolhedora diante das próprias dificuldades favoreceu para o aumento de apreciação corporal, na relação com a aparência física e no afeto positivo. Tais resultados reforçam que intervenções baseadas em autocompaixão podem ser uma estratégia promissora para a promoção de uma relação mais saudável com o próprio corpo.

Assim, partindo do pressuposto de que a associação entre apreciação corporal e percentual de gordura corporal em adultos ainda não está plenamente elucidada, este estudo pode contribuir de forma relevante para a literatura. A compreensão mais aprofundada dessas associações e de seus mecanismos subjacentes pode auxiliar tanto nos processos de avaliação quanto no delineamento de intervenções voltadas a pessoas que sofrem com insatisfação corporal e desfechos psicológicos associados.

REFERÊNCIAS

- ALLAN, S.; GILBERT, P.; GOSS, K. An exploration of shame measures: II. Psychopathology. *Personality and Individual Differences*, [S.l.], v. 17, n. 5, p. 719-722, 1994.
- ALVEAR-FERNÁNDEZ, C. *et al.* Estilos de alimentación y su asociación con apreciación corporal, internalización del sesgo del peso y autocompasión. *Terapia Psicológica*, [S.l.], v. 39, n. 2, p. 199-214, 2021.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 5th ed. Text rev. (DSM-5-TR). Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2022.
- ANDREW, R.; TIGGEMANN, M.; CLARK, L. Predicting body appreciation in young women: an integrated model of positive body image. *Body Image*, [S.l.], v. 18, p. 34-42, 2016.
- ARAYA-VÉLIZ, C.; DURÁN, C. Compasión y auto-compasión: impacto sobre la regulación emocional. *Psicología, Reflexão e Crítica*, [S.l.], v. 28, n. 3, p. 1-15, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA. *Diretrizes brasileiras de obesidade*. São Paulo, 2021.
- BAKALIM, Orkide. Self-confident approach in coping with stress and social appearance anxiety of Turkish university students: the mediating role of body appreciation. *International Journal of Higher Education*, Toronto, v. 5, n. 4, p. 134–143, 2016. doi:10.5430/ijhe.v5n4p134.
- BERKING, M.; WHITLEY, B. Emotion regulation: Definition and relevance for mental health. In: *Affect Regulation Training: a practitioners' manual*, [S.l.], p. 5–17, 2014.. doi: 10.1007/978-1-4939-1022-9_2.
- BRASIL, K. M. *et al.* Social media and body image: Relationships between social media appearance preoccupation, self-objectification, and body image. *Body Image*, [S.l.], v. 51, Article 101767, 2024. doi: 10.1016/j.bodyim.2024.101767.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. *Vigitel Brasil 2021: Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: Estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2021*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.
- BRAUN, T. D. *et al.* Shame and self-compassion as risk and protective mechanisms of the internalized weight bias and emotional eating link in individuals seeking bariatric surgery. *Obesity Surgery*, [S.l.], v. 31, n. 7, p. 3177–3187, 2021. doi: 10.1007/s11695-021-05411-2.
- BRAUN, T. D.; KELLER, P. S.; LIGUORI, G. Shame and self-compassion as predictors of disordered eating behaviors and intuitive eating in college women. *Eating Behaviors*, [S.l.], v. 43, p. 101557, 2021. doi: 10.1016/j.eatbeh.2021.101557.

- BURCU, E. The role of self-esteem, body image, and body mass index in predicting depression among Turkish university students. *Quality & Quantity*, [S.l.], v. 55, n. 5, p. 1569–1583, 2021. doi: 10.1007/s11135-020-01056-0.
- BURYCHKA, D.; MIRAGALL, M.; BAÑOS, R. M. The role of body compassion in the risk of eating disorders: mediational effects of body appreciation and body shame. *Psicothema*, Oviedo, v. 36, n. 1, p. 36-45, 2024. doi: 10.7334/psicothema2023.48.
- CABRAL, M. C. *et al.* Association of body image perception and (dis)satisfaction with adiposity in adults: the Pró-Saúde study. *PLOS ONE*, San Francisco, v. 19, n. 6, p. e0304987, 2024. doi: 10.1371/journal.pone.0304987.
- CARTER, A.; GILBERT, P.; KIRBY, J. N. Compassion focused therapy for body weight shame: a mixed methods pilot trial. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, [S.l.], 2021. No prelo. doi: 10.1002/cpp.2488.
- CASH, T. F.; FLEMING, E. C. The impact of body image experiences: Development of the Body Image Quality of Life Inventory. *International Journal of Eating Disorders*, [S.l.], v. 31, n. 4, p. 455–460, 2002. doi: 10.1002/eat.10033.
- CASH, T. F.; SMOLAK, L. (ed.). *Body image: A handbook of science, practice, and prevention*. 2. ed. New York, NY: The Guilford Press, 2011.
- COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed., 1988. doi: 10.4324/9780203771587.
- CUNHA, M. I. V. A. *et al.* Measuring shame in adolescents: validation studies of the External and Internal Shame Scale in a community sample. *Child & Youth Care Forum*, [S.l.], v. 45, n. 4, p. 571-590, 2016.
- CZEPCZOR-BERNAT, K. The role of body shame and age on appearance-based exercise and positive body image in women from Poland: Preliminary results of a cluster analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [S.l.], v. 19, n. 23, p. 15741, 2022. doi: 10.3390/ijerph192315741.
- DAIRI, G. *et al.* Effect of intermittent fasting on body image satisfaction and appreciation among Saudi adults. *Cureus*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. e33468, 2023. doi: 10.7759/cureus.33468.
- DE WET, A. J.; LANE, B. R.; MULGREW, K. E. A Randomised Controlled Trial Examining the Effects of Self-Compassion Meditations on Women's Body Image. *Body Image*, [S.l.], v. 35, p. 22-29, 2020. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.07.009. Epub 2020 Aug 23. PMID: 32846388.
- DUARTE, C. *et al.* Body image and college women's quality of life: The importance of being self-compassionate. *Journal of Health Psychology*, [S.l.], v. 20, n. 6, p. 754-764, 2015.
- FIGUEROA, D. G. *et al.* Weight stigma and mental health symptoms: mediation by perceived stress. *Frontiers in Psychiatry*, Lausanne, v. 16, p. 1587105, 2025.
- GATTARIO, K. H. *et al.* How is men's conformity to masculine norms related to their body image? *Body Image*, [S.l.], v. 15, p. 1–9, 2015. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.04.010.

GBD 2021 RISK FACTORS COLLABORATORS. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*, [S.l.], v. 403, p. 2162–2203, 2024. doi: 10.1016/S0140-6736(24)00933-4.

GELLER, S. *et al.* Self-compassion mediates the relationship between attachment anxiety and body appreciation in women and men: evidence from Israel. *Personality and Individual Differences*, Oxford, v. 179, p. 110912, 2021. doi: 10.1016/j.paid.2021.110912.

GILES, E.; WALLER, G. Body Image Surveys to Address Social Appearance Anxiety in Women at Risk of Eating Psychopathology: An Acceptability, Feasibility and Preliminary Efficacy Study, Using a Wait-List Randomized Controlled Design. *International Journal of Eating Disorders*, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 371–383, 2026. doi: 10.1002/eat.24590. Epub 2025 Nov 5. PMID: 41194550; PMCID: PMC12884258.

GILLEN, M. M. Associations between positive body image and indicators of men's and women's mental and physical health. *Body Image*, [S.l.], 13, 67–74, 2015. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.01.002.

GODOY-IZQUIERDO, D.; LARA PALOMO, I. Self-compassion and well-being in adolescents: The mediating role of body appreciation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [S.l.], v. 17, n. 20, p. 1–15, 2020. doi: 10.3390/ijerph17207646.

GRUSZKA, W. *et al.* Is there a difference in body size dissatisfaction between those with obesity seeking and not seeking treatment for obesity? *BMC Public Health*, [S.l.], v. 21, p. 1754, 2021. doi: 10.1186/s12889-021-11811-6.

GRUSZKA, W. *et al.* Perception of body size and body dissatisfaction in adults. *Scientific Reports*, [S.l.], v. 12, p. 1159, 2022. doi: 10.1038/s41598-021-04706-6.

GUEST, E. *et al.* A systematic review of interventions aiming to promote positive body image in children and adolescents. *Body Image*, [S.l.], v. 42, p. 58–74, 2022. doi: 10.1016/j.bodyim.2022.04.009.

HAYES, A. F. *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. A Regression-Based Approach*. 2. ed. New York, NY: The Guilford Press, 2018.

HE, J. *et al.* Meta-analysis of gender differences in body appreciation. *Body Image*, [S.l.], v. 33, p. 90–100, 2020.

HOMAN, K. J. Self-compassion moderates body comparison and appearance self-worth's inverse relationships with body appreciation. *Body Image*, [S.l.], v. 15, p. 1–7, 2015.

JUNQUEIRA, A. C. P. *et al.* Translation and validation of a Brazilian Portuguese version of the Body Appreciation Scale-2 in Brazilian adults. *Body Image*, [S.l.], v. 31, p. 160–170, 2019.

LAPORTA-HERRERO, I. *et al.* Attachment, body appreciation, and body image quality of life in adolescents with eating disorders. *Eating Disorders*, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 168–181, 2022. doi: 10.1080/10640266.2020.1763112.

LINARDON, J. *et al.* Body appreciation and its psychological correlates: A systematic review and meta-analysis. *Body Image*, [S.l.], v. 42, p. 287–296, 2022. doi: 10.1016/j.bodyim.2022.07.003.

- LIU, Z.-H. *et al.* Gender differences in body appreciation and its associations with psychiatric symptoms among Chinese college students: a nationwide survey. *Frontiers in Psychiatry*, [S.l.], v. 13, p. 771398, 2022.
- LUCIBELLO, K. M. *et al.* Mediating role of body-related shame and guilt in the relationship between weight perceptions and lifestyle behaviours. *Obesity Science & Practice*, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 365-372, 2020. doi: 10.1002/osp4.415.
- MARTA-SIMÕES, J.; FERREIRA, C.; MENDES, A. Exploring the effect of external shame on body appreciation among Portuguese young adults: The role of self-compassion. *Eating Behaviors*, [S.l.], v. 23, p. 174–179, 2016. doi: 10.1016/j.eatbeh.2016.10.006.
- MATOS, M.; PINTO-GOUVEIA, J.; DUARTE, C. Other as Shamer: Versão portuguesa e propriedades psicométricas de uma medida de vergonha externa. *Manuscript submitted for publication*. 2011.
- MEHAK, A.; FRIEDMAN, A.; CASSIN, S. E. Self-objectification, weight bias internalization, and binge eating in young women: testing a mediational model. *Body Image*, [S.l.], v. 24, p. 111-115, 2018.
- MELO, D.; OLIVEIRA, S.; FERREIRA, C. A relação entre vergonha externa e interna e compulsão alimentar: o papel mediador da vergonha relacionada à imagem corporal e da fusão cognitiva. *Eat Weight Disord*, [S.l.], v. 25, p. 1703–1710, 2020. doi: 10.1007/s40519-019-00811-8.
- MENDES, A. L.; CANAVARRO, M. C.; FERREIRA, C. How psychological inflexibility mediates the association between general feelings of shame with body image-related shame and eating psychopathology severity? *Appetite*, [S.l.], v. 163, p. 105228, 2021. doi: 10.1016/j.appet.2021.105228.
- MILLS, J. S.; MINISTER, C.; SAMSON, L. Enriching sociocultural perspectives on the effects of idealized body norms: integrating shame, positive body image, and self-compassion. *Frontiers in Psychology*, Lausanne, v. 13, p. e983534, 2022. doi:10.3389/fpsyg.2022.983534.
- MORENO, A. L. *et al.* Factor structure, reliability, and item parameters of the Brazilian-Portuguese version of the GAD-7 questionnaire. *Trends in Psychiatry and Psychotherapy*, [S.l.], v. 38, n. 5, p. 213–219, 2016. doi: 10.1590/2237-6089-2015-0084.
- NAZ, S. *et al.* Impact of body appreciation and social appearance anxiety on life satisfaction among young adults. *VFAST Transactions on Education and Social Sciences*, Rawalpindi, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 208–219, 2023.
- NECHITA, D. M.; DAVID, D. Shame facets as predictors of problematic eating behaviors: An ecological momentary assessment study. *Behaviour Research and Therapy*, [S.l.], v. 168, p. 104381, 2023. doi: 10.1016/j.brat.2023.104381.
- NEFF, K. Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. *Self and Identity*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 85–101, 2003. doi: 10.1080/15298860309032.
- NEFF, K. *Self-compassion: The proven power of being kind to yourself*. William Morrow, 2019.

NEFF, K. D. The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity*, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 223–250, 2003. doi: 10.1080/15298860309027.

NEFF, K. D.; GERMER, C. K. A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. *Journal of Clinical Psychology*, [S.l.], v. 69, n. 1, p. 28–44, 2013. doi: 10.1002/jclp.21923.

NIGHTINGALE, B. A.; CASSIN, S. E. Self-compassion may have benefits for body image among women with a higher body mass index and internalized weight bias. *Healthcare*, [S.l.], v. 11, n. 7, 2023.

O’LOGHLEN, E.; GRANT, S.; GALLIGAN, R. Shame and binge eating pathology: A systematic review. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, [S.l.], v. 29, n. 1, p. 147–163, 2022. doi: 10.1002/cpp.2615.

OLIVEIRA, M. R.; MACHADO, J. S. A. O insustentável peso da autoimagem: (re)apresentações na sociedade do espetáculo. *Ciência & Saúde Coletiva*, [S.l.], v. 26, n. 7, p. 2663–2672, 2021. doi: 10.1590/1413-81232021267.08782021.

OLSON, K. L. L.; THAXTON, L.; EMERY, C. F. Targeting body dissatisfaction among women with overweight or obesity: a proof-of-concept pilot study. *International Journal of Eating Disorders*, Hoboken, v. 51, n. 9, p. 979–984, 2018. doi: 10.1002/eat.22874.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Obesity and overweight*. Genebra: World Health Organization, 2022. Disponível em <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Acesso em: 24 out. 2025.

PHELAN, S. M. *et al.* Impact of weight bias and stigma on quality of care and outcomes for patients with obesity. *Obesity Reviews*, [S.l.], v. 16, n. 4, p. 319–326, 2015. doi: 10.1111/obr.12266.

PUHL, R. M. *et al.* The roles of experienced and internalized weight stigma in healthcare experiences in six countries. *PLOS ONE*, San Francisco, v. 16, n. 6, e0251566, 2021. doi: 10.1371/journal.pone.0251566.

PIMENTA, I T.; COELHO, G. M. O.; SOARES, E. A. Is body image perception and (dis)satisfaction associated with anthropometric profile in older women? *Revista de Nutrição*, Campinas, v. 34, p. e200179, 2021. doi: 10.1590/1678-9865202134e200179.

PINHÃO, C. *et al.* Percepção da imagem corporal por crianças e cuidadores: Um instrumento de mudança? *Gazeta Médica*, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 179–187, 2023. doi: 10.29315/gm.v10i3.1031.

PULLMER, R. *et al.* Factors linking perceived discrimination and weight bias internalization to body appreciation and eating pathology: A moderated mediation analysis of self-compassion and psychological distress. *Stigma and Health*, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 494–501, 2021. doi: 10.1037/sah0000334.

RAQUE, T. L. *et al.* Pathways by which self-compassion improves positive body image: a qualitative analysis. *Behavioral Sciences*, Basel, v. 13, n. 11, p. e0939, 2023.

RASPOVIC, A. *et al.* Body image profiles combining body shame, body appreciation and body mass index differentiate dietary restraint and exercise amount in women. *Body Image*, [S.l.], v. 46, p. 117–122, 2023. doi: 10.1016/j.bodyim.2023.01.003.

- RAZMUS, M. Body appreciation and body-related pride in normal-weight and overweight/obese individuals: Does romantic relationship matter? *Perspectives in Psychiatric Care*, [S.l.], v. 54, n. 1, p. 1–7, 2018. doi: 10.1111/ppc.12343.
- ROBBINS, A. R.; REISSING, E. D. Appearance dissatisfaction, body appreciation, and sexual health in women across adulthood. *Archives of Sexual Behavior*, [S.l.], v. 47, p. 703–714, 2018.
- ROBINSON, L. *et al.* Idealised media images: *The effect of fitspiration imagery on body satisfaction and exercise behaviour*. *Body Image*, [S.l.], v. 22, p. 65–71, 2017. Epub 2017 Jun 24. PMID: 28654826.
- SALARIAN KALEJI, Z. *et al.* The link between external and internal body-image shame and binge eating in men and women: the mediating role of self-criticism. *Iran J Psychiatry Behav Sci*, [S.l.], v. 15, n. 4, p. e114288, 2021. doi: 10.5812/ijpbs.114288.
- SANZARI, C. M. *et al.* The impact of social media use on body image and disordered eating behaviors: content matters more than duration of exposure. *Body Image*, [S.l.], v. 45, p. 230–240, 2023.
- SCHRAMME, T. Health as complete well-being: the WHO definition and beyond. *Public Health Ethics*, Oxford, v. 16, n. 3, p. 210–222, 2023. doi: 10.1093/phe/phad013.
- SECCHI, K.; CAMARGO, B. V.; BERTOLDO, R. B. Percepção da imagem corporal e representações sociais do corpo. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, [S.l.], v. 25, n. 2, p. 229–236, 2009. doi: 10.1590/S0102-37722009000200011.
- SINGH, N.; STEWART, R. A. H.; BENATAR, J. R. Intensity and duration of lifestyle interventions for long-term weight loss and association with mortality: a meta-analysis of randomised trials. *BMJ Open*, London, v. 9, n. 8, p. e029966, 2019. Disponível em: <https://bmjopen.bmj.com/content/9/8/e029966>.
- SICK, K. *et al.* Does self-compassion buffer the detrimental effect of body shame on depressive symptoms? *Body Image*, Amsterdam, v. 34, p. 175–183, 2020. doi: 10.1016/j.bodyim.2020.05.012.
- SOLOMON-KRAKUS, S.; SABISTON, C. M. Body checking is associated with weight- and body-related shame and weight- and body-related guilt among men and women. *Body Image*, [S.l.], v. 23, p. 80–84, 2017. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.08.005. Epub 2017 Sep 5. PMID: 28886393.
- SOUZA, L. K. D.; HUTZ, C. S. Adaptation of the Self-Compassion Scale for use in Brazil: Evidences of construct validity. *Temas em Psicologia*, [S.l.], v. 24, n. 2, p. 397–406, 2016.
- SPITZER, R. L. *et al.* A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, [S.l.], v. 166, n. 10, p. 1092–1097, 2006. doi: <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>.
- STYK, W.; WOJTOWICZ, E.; ZMORZYNSKI, S. I don't want to be thin! Fear of weight change is not just a fear of obesity: research on the Body Mass Anxiety Scale. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 20, p. 2888, 2023. doi: 10.3390/ijerph20042888.

- SUWALSKA, J. *et al.* Determinants of weight status and body, health and life satisfaction in adults: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, London, v. 24, n. 1, p. 734, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38794722/>.
- SWAMI, V. *et al.* The associations of narcissism, self-esteem, and perfectionism with positive body image. *Body Image*, [S.l.], v. 51, p. 101768, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2024.101768>.
- TOOLE, A. M.; LOPARO, D.; CRAIGHEAD, L. W. Self-compassion and dissonance-based interventions for body image distress in young adult women. *Body Image*, [S.l.], v. 38, p. 191–200, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2021.04.001>.
- TORRES, S. *et al.* A Comprehensive Study of Positive Body Image as a Predictor of Psychological Well-Being in Anorexia Nervosa. *Nutrients*, [S.l.], v. 16, n. 11, p. 1787, 2024. doi: 10.3390/nu16111787. PMID: 38892718; PMCID: PMC11174434.
- TURK, F.; KELLETT, S.; WALLER, G. Determining the potential links of self-compassion with eating pathology and body image among women and men: a cross-sectional mediational study. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, [S.l.], v. 28, n. 6, p. 1436-1448, 2021.
- TURK, Fidan; KELLETT, Stephen; WALLER, Glenn. Comparing self-compassion versus body exposure for adult women with moderate to severe body dissatisfaction: a feasibility and pilot trial. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, [S.l.], v. 29, n. 4, p. 1475-1480, 2022.
- TYLKA, T. L.; WOOD-BARCALOW, N. L. What is and what is not positive body image? Conceptual foundations and construct definition. *Body Image*, [S.l.], v. 14, p. 118-129, 2015. doi: 10.1016/j.bodyim.2015.04.001. Epub 2015 Apr 25. PMID: 25921657.
- TYLKA, T. L.; WOOD-BARCALOW, N. L. The Body Appreciation Scale-2: item refinement and psychometric evaluation. *Body Image*, [S.l.], v. 12, p. 53-67, 2015.
- VIZIN, G. *et al.* Body-Related Shame or Guilt? Dominant Factors in Maladaptive Eating Behaviors Among Hungarian and Norwegian University Students. *Heliyon*, [S.l.], v. 8, n. 2, p. e08817, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08817>.
- WACHHOLZ, L. B.; SANTOS, M. C. M. O.; RIBEIRO, M. L. A influência da imagem corporal no comportamento alimentar em adolescentes de uma escola particular do vale do Itajaí-SC. *RBONE - Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento*, [S.l.], v. 15, n. 94, p. 374-379, 2022.
- WEINBERGER, N.-A. *et al.* Body dissatisfaction in individuals with obesity compared to normal-weight individuals: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Facts*, [S.l.], v. 9, n. 6, p. 424–441, 2016. <https://doi.org/10.1159/000454837>.
- WOOD-BARCALOW, N. L.; TYLKA, T. L.; AUGUSTUS-HORVATH, C. L. “But I like my body”: Positive body image characteristics and a holistic model for young-adult women. *Body Image*, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 106–116, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2010.01.001>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO European regional obesity report 2022*. WHO: Regional Office for Europe, 2022. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/353747>. Acesso em: 23 out. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Obesity: preventing and managing the global epidemic*. Report of a WHO consultation. Geneva: WHO, 2000. (WHO Technical Report Series, 894).

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Anxiety disorders*. Geneva: World Health Organization, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>. Acesso em: 11 out. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO, 1948. Disponível em: <https://www.who.int/about/governance/constitution>. Acesso em: 11 out. 2025.

YAHIA, N. *et al.* Dieting practices and body image perception among Lebanese university students. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 21-28, 2011.

ZANOLLI, N. M. B. C. *et al.* Fatores associados à insatisfação corporal de crianças e adolescentes de escola pública em município da Zona da Mata mineira. *Revista APS*, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 106-118, 2019.

ZHU, J. *et al.* The mechanism of body appreciation influencing social anxiety among college students: the mediating role of social suspiciousness. *Asian Journal of Psychiatry*, [S.l.], 2025. doi: 10.1016/j.ajp.2025.103722.

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nº do projeto GPPG ou CAAE _____

Título do Projeto: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO MINDFUL EATING E CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS NEUROCOGNITIVOS, INFLAMATÓRIOS E METABÓLICOS DE PACIENTES COM SINTOMAS ANSIOSOS E OBESIDADE

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é estudar o desempenho de certas funções do cérebro em conjunto com algumas substâncias no sangue de pessoas com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e obesidade. Esta pesquisa está sendo realizada pelo Programa de Transtornos de Ansiedade (PROTAN) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Se você aceitar o convite, sua participação na pesquisa envolverá responder alguns questionários e entrevistas sobre sua saúde física, mental e sobre sua alimentação; realizar algumas tarefas (testes) neurocognitivas para entender alguns aspectos do funcionamento do cérebro, como o controle de impulso, por exemplo; fazer uma avaliação nutricional para identificar sua composição corporal; fazer uma coleta de sangue, para avaliarmos alguns fatores do seu metabolismo, inflamatórios e genéticos.

Os possíveis riscos ou desconfortos decorrentes da participação na pesquisa são o desconforto com a coleta de sangue e pelo tempo de resposta dos questionários e tarefas.

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são as avaliações psiquiátrica e nutricional, precisas realizadas por profissionais capacitados, além de orientações de qualidade de vida.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição.

Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos.

Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal.

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. O material biológico coletado poderá ser armazenado para análises futuras com novos

biomarcadores ou genes. Os resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados.

Se você se encaixar nos critérios da fase II (uma intervenção de cinco semanas), será convidado a participar seguindo os mesmos parâmetros éticos descritos acima. Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, pelo telefone (51) 33598294, com a pesquisadora Natasha Kim de Oliveira da Fonseca, pelo telefone (54) 991912372 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo e-mail cep@hcpa.edu.br, telefone (51) 33596246 ou Av. Protásio Alves, 211 - Portão 4 - 5º andar do Bloco C - Rio Branco - Porto Alegre/RS, de segunda à sexta, das 8h às 17h.

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para os pesquisadores.

Nome do participante da pesquisa

Assinatura

Nome do pesquisador que aplicou o Termo

Assinatura

Local e Data: _____

APÊNDICE B - PESQUISA SOBRE COMPORTAMENTO ALIMENTAR E ANSIEDADE



The poster is divided into two main sections. The top section has a light blue background and contains the logos of 'HOSPITAL DE CLÍNICAS PORTO ALEGRE - RS' and 'UFRGS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL'. It asks three questions: 'Você tem entre 18 e 50 anos?', 'Gostaria de melhorar sua alimentação?', and 'É de Porto Alegre?'. Below these questions is a white rectangular box with a blue border and a blue circle at the top, containing the text 'PARTICIPAÇÃO GRATUITA'. The bottom section has a dark purple background and features the title 'PESQUISA SOBRE COMPORTAMENTO ALIMENTAR E ANSIEDADE' in white. It lists five activities under the heading 'O que será feito?': 'Coleta de dados pessoais', 'Avaliação do consumo alimentar', 'Avaliação da composição corporal', 'Avaliação psiquiátrica', and 'Coleta de exames bioquímicos'. Each activity is preceded by a small icon. At the bottom left of this section is an illustration of a person with long dark hair, wearing a purple shirt, holding a blue heart. To the right of the illustration, white text states: 'Participantes receberão a avaliação da sua composição corporal por Bioimpedância (massa muscular e percentual de gordura), exames laboratoriais e orientações nutricionais.'

HOSPITAL DE CLÍNICAS
PORTO ALEGRE - RS

UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

Você tem entre 18 e 50 anos?
Gostaria de melhorar sua alimentação?
É de Porto Alegre?

**PARTICIPAÇÃO
GRATUITA**

**PESQUISA SOBRE
COMPORTAMENTO ALIMENTAR
E ANSIEDADE**

O que será feito?

- Coleta de dados pessoais
- Avaliação do consumo alimentar
- Avaliação da composição corporal
- Avaliação psiquiátrica
- Coleta de exames bioquímicos

Participantes receberão a avaliação da sua composição corporal por Bioimpedância (massa muscular e percentual de gordura), exames laboratoriais e orientações nutricionais.

Pesquisa sobre Comportamento Alimentar e Ansiedade no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Estamos disponibilizando exames (incluindo percentual de gordura corporal), avaliação psiquiátrica e orientações nutricionais para os pacientes voluntários.

Para saber mais informações, entre em contato pelo (051) 99198-6747.

APÊNDICE C - ORIENTAÇÃO PARA EXAMES



HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS



Nº do projeto CAAE: 66476322.5.0000.5327

Título do Projeto: Avaliação do efeito do *Mindful Eating* e caracterização dos parâmetros neurocognitivos, inflamatórios e metabólicos de pacientes com ansiedade e obesidade.

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Gisele Gus Manfro

ORIENTAÇÃO PARA EXAMES

EXAME DE SANGUE:

Este exame necessita jejum de 12 horas.

BIOIMPEDÂNCIA:

O exame de bioimpedância é totalmente indolor e rápido, mas assim como outros exames biológicos requer algumas preparações da pessoa antes de se submeter ao teste.

Orientações:

- Manter 4 horas de jejum absoluto (alimento e água);
- Evitar fumar por um período mínimo de 12 horas antes do exame;
- Procurar ingerir em torno de 2L de água no dia anterior ao exame;
- Evitar exercício físico intenso nas 24h anteriores a avaliação;
- Não fazer sauna nas 24h anteriores a avaliação;
- Não ingerir agentes diuréticos 24h antes a avaliação;
- Não estar febril no dia do teste;
- Retirar todas as jóias, relógio e metais durante o exame;
- Informar o avaliador sobre os medicamentos que estão sendo utilizados;
- Esvaziar a bexiga antes da realização do exame;
- Não consumir bebidas alcoólicas 2 dias antes do exame;
- Evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em cafeína (chocolates, chás escuros, chimarrão e café) nos dois dias que antecedem o exame;
- Não estar em período menstrual (mulheres);

Quem não pode realizar o exame:

- Pessoas com marca-passo, ou outro aparelho eletrônico interno ao corpo que dê suporte a vida;
- Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez;
- Pessoas com placas metálicas em ambos os braços direito e perna esquerda, ou vice-versa (braço esquerdo e perna direita), pois pode resultar em uma leitura errada de bioimpedância.

ANEXO A - TRANSTORNO DE ANSIEDADE | GAD - 7

Nas últimas 2 semanas, o quão frequentemente você tem se incomodado com os problemas?

	Raramente	Alguns dias	Mais da metade dos dias	Quase todos os dias
1) Sentiu-se nervoso, ansioso, inquieto	() 0	() 1	() 2	() 3
2) Não conseguiu parar de se preocupar ou controlar suas preocupações	() 0	() 1	() 2	() 3
3) Se preocupou demais com diferentes coisas	() 0	() 1	() 2	() 3
4) Dificuldade em relaxar	() 0	() 1	() 2	() 3
5) Ficou tão agitado(a) que foi difícil ficar parado(a)	() 0	() 1	() 2	() 3
6) Ficou facilmente aborrecido(a) irritado(a)	() 0	() 1	() 2	() 3
7) Sentiu-se com medo, como se algo ruim pudesse acontecer	() 0	() 1	() 2	() 3

ANEXO B - ESCALA DE APRECIÇÃO CORPORAL *BODY APPRECIATION*
SCALE – 2 (BAS – 2)

Instruções: Por favor, indique se a afirmativa abaixo é verdadeira em relação a você.

	Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre
1. Eu respeito meu corpo.					
2. Eu me sinto bem com meu corpo.					
3. Eu sinto que meu corpo tem, pelo menos, algumas qualidades positivas.					
4. Eu tenho uma atitude positiva em relação ao meu corpo.					
5. Eu sou atento(a) às necessidades do meu corpo.					
6. Eu sinto amor pelo corpo.					
7. Eu aprecio as características diferentes e únicas do meu corpo.					
8. Meu comportamento revela minha atitude positiva em relação ao meu corpo; por exemplo, mantenho minha cabeça erguida e sorrio.					
9. Eu me sinto confortável com meu corpo.					
10. Eu sinto que sou bonito(a) mesmo que eu seja diferente das imagens de pessoas atraentes da mídia (exemplo: modelos, atrizes/atores).					

ANEXO C - ESCALA DE AUTOCOMPAIXÃO - *SELF-COMPASSION SCALE* (SCS)

Como eu geralmente lido comigo em momentos difíceis

Por favor, leia com cuidado antes de responder. Para cada frase, marque o número que mostra com que frequência você se comporta da forma descrita. Use a escala de 1 até 5 para marcar sua escolha, sendo que 1 corresponde a “ Quase nunca” (N), e 5 significa “ Quase sempre” (S). Não existem respostas certas ou erradas. Gostaríamos de sua opinião pessoal. Você pode escolher qualquer número de 1 até 5.

	Q N				Q S
	1	2	3	4	5
Por favor, para cada frase, marque com um “X” a sua resposta.					
1. Sou realmente crítico e severo com meus próprios erros e defeitos.					
2. Quando fico “pra baixo”, não consigo parar de pensar em tudo que está errado comigo.					
3. Quando as coisas vão mal para mim, vejo as dificuldades como parte da vida e que acontecem com todo mundo.					
4. Quando penso nos meus defeitos, eu me sinto realmente isolado do resto do mundo.					
5. Tento ser amável comigo quando me sinto emocionalmente mal.					
6. Quando eu falho em algo importante para mim, fico totalmente consumido por sentimentos de incompetência.					
7. Quando me sinto realmente mal, lembro que há outras pessoas no mundo se sentindo como eu.					
8. Quando as coisas estão realmente difíceis, costumo ser duro comigo mesmo.					

	Q N				Q S
Por favor, para cada frase, marque com um "X" a sua resposta.	1	2	3	4	5
9. Quando algo me deixa aborrecido, tento buscar equilíbrio emocional.					
10. Quando percebo que fui inadequado, tento lembrar que a maioria das pessoas também passa por isso.					
11. Sou intolerante e impaciente com os aspectos de que não gosto na minha personalidade.					
12. Quando estou passando por um momento realmente difícil, eu me dou o apoio e o cuidado de que preciso.					
13. Quando fico "pra baixo", sinto que a maioria das pessoas é mais feliz do que eu.					
Por favor, para cada frase, marque com um "X" a sua resposta.	1	2	3	4	5
14. Quando algo doloroso acontece, tento ver a situação de forma equilibrada.					
15. Tento entender meus defeitos como parte da condição humana.					
16. Quando vejo características que eu não gosto em mim, sou duro comigo mesmo.					
17. Quando eu falho em algo importante para mim, tento ver as coisas por outro ângulo.					
18. Quando passo por dificuldades emocionais, costumo pensar que as coisas são mais fáceis para as outras pessoas.					
19. Sou bondoso comigo quando estou passando por algum sofrimento.					
20. Quando algo me deixa incomodado, sou completamente tomado por sentimentos negativos.					

Por favor, para cada frase, marque com um “X” a sua resposta.	Q N				Q S
	1	2	3	4	5
21. Costumo ser um pouco insensível comigo quando estou sofrendo.					
22. Quando fico “pra baixo”, tento aceitar e entender meus sentimentos.					
23. Sou tolerante com meus próprios erros e defeitos.					
24. Quando algo doloroso acontece comigo, costumo reagir de forma exagerada.					
25. Quando eu falho em algo importante para mim, costumo me sentir muito sozinho nessa situação.					
26. Tento ser compreensivo e paciente com os aspectos da minha personalidade dos quais não gosto.					

ANEXO D - ESCALA DA VERGONHA | OTHER AS SHAMER SCALE (OAS)

Esta seção contém declarações sobre o sentimento de vergonha. Leia cuidadosamente cada declaração e responda marcando a alternativa que melhor se aplica a você.

0= Nunca 1= Raramente 2= Às vezes 3= Frequentemente 4= Quase sempre

1. Sinto que as outras pessoas não me vêem como sendo suficientemente bom (boa).	0	1	2	3	4
2. Penso que as outras pessoas me desprezam.	0	1	2	3	4
3. Sinto-me inseguro (a) acerca das opiniões dos outros sobre mim.	0	1	2	3	4
4. As outras pessoas olham-me como se eu não estivesse à altura deles(as).	0	1	2	3	4
5. As outras pessoas vêem-me como se eu fosse pequeno(a) e insignificante.	0	1	2	3	4
6. As outras pessoas vêem-me como se eu fosse uma pessoa defeituosa.	0	1	2	3	4
7. As pessoas vêem-me como pouco importante em relação aos outros.	0	1	2	3	4
8. Os outros pensam que há qualquer coisa que falta em mim.	0	1	2	3	4